



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Epiverse
TRACELAC

Curso en ciencia de datos
en salud pública y modelamiento de
enfermedades infecciosas

Las pandemias de cólera

El cólera es una infección diarreica aguda causada por ingerir agua o alimentos contaminados con el bacilo *Vibrio cholerae* que afecta solo a los humanos y puede ser letal en cuestión de horas. El periodo de incubación de esta infección es corto, pues puede variar entre dos horas a cinco días.

Asimismo, esta enfermedad afecta mayoritariamente a comunidades vulnerables sin condiciones apropiadas de alcantarillado, acueducto e higiene. Sin tratamientos —como la pronta administración de sales de rehidratación oral— entre el 20 al 50 % de los casos sintomáticos muere en horas o días a causa de una deshidratación severa por diarrea. Con tratamiento oportuno, la letalidad es inferior al 1 %. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países.



Fuente: **Pixnio**.

La primera pandemia documentada se originó en 1817 en Asia (*Azizi et. al., 2010*), en el noreste del subcontinente indio en el delta del río Ganges (Bangladesh e India). Esta primera epidemia duró 6 años, y provocó una alta mortalidad en la India, extendiéndose luego por China, África y Europa de 1829 a 1851.

Esta pandemia de cólera marcó igualmente la historia formal del inicio de la epidemiología moderna con el trabajo del emblemático doctor John Snow. Este trascendental tema lo revisaremos en detalle en la Unidad 2: Teoría Epidémica.

A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo en seis pandemias. La última (séptima) pandemia comenzó en Asia meridional en 1961 y llegó a África en 1971 y a las Américas en 1991, dejando miles de muertos en estos continentes.

Sin embargo, según la OMS (2023) desde mediados de 2021 ha ocurrido un fuerte aumento en la séptima pandemia de cólera, con numerosos brotes de gran magnitud y alcance. Esto se ha traducido en la propagación a áreas previamente libres de cólera y tasas de mortalidad preocupantemente altas.

Hasta febrero de 2023, al menos 18 países siguen notificando casos de cólera. Situaciones como crisis humanitarias, conflictos y el cambio climático aumentan el riesgo de propagación. En estas circunstancias propias del siglo XXI, la infraestructura crucial de manejo de agua potable y no potable se pone en riesgo, incrementando la posibilidad de brotes y grandes epidemias de cólera.

Por otra parte, el cólera puede causar complicaciones graves en mujeres embarazadas, tales como nacimientos prematuros o la pérdida fetal, con tasas que varían del 2 % al 36 %. Además, dado que las mujeres embarazadas y lactantes son más vulnerables a la desnutrición, corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones fatales si contraen cólera (Moro et. al., 2017). Por otra parte, labores asociadas con roles tradicionales amplifica la vulnerabilidad de niñas y mujeres en contraer cólera cuando, por ejemplo, van a buscar agua, preparan la comida, cuidan a los familiares enfermos y limpian las letrinas.

Última gran epidemia continental de cólera en las Américas

La última epidemia de cólera en América Latina registró cerca de un millón de casos y más de 9.000 muertes entre enero de 1991 y diciembre de 1993. Esta epidemia se propagó rápidamente de un país a otro, afectando durante tres años a todos los países de América Latina excepto Uruguay y el Caribe.

Si bien hoy en día se desconocen los factores que propiciaron esta epidemia, algunos estudios de casos y controles realizados en Perú, donde se inició la epidemia, mostraron que los principales factores de riesgo de infección fueron: el manejo del agua, el consumo de frutas y verduras sin lavar.

Caso Haití 2010

En el contexto del terremoto de Haití en 2010, se registró un brote de cólera que comenzó en octubre de ese año y afectó a más de 93.000 personas, causando la muerte a más de 2000 personas. Este brote fue considerado uno de los más grandes y devastadores de cólera en la historia reciente (Chin et. al., 2011).

El brote de cólera en Haití se extendió rápidamente debido a la afectación de las infraestructuras de agua potable y saneamiento adecuado, así como a las condiciones de vida precarias. Además, la aglomeración de personas en campamentos temporales facilitó la propagación de la enfermedad.



Fuente: Wikipedia.